

ARTIGOS · POLÍTICA

Quando a democracia se fortalece, as entidades de classe se enfraquecem: o paradoxo do Brasil de 2026

Um ato de prevenção do médico · e não de prevenção médica · em um país cada vez mais guiado por narrativas.

Guilherme Augusto Turbino Ribeiro · Política · 9 min de leitura · 12 de janeiro de 2026

Em 07/01/2026, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu uma queda durante a madrugada, resultando em traumatismo cranioencefálico (TCE) leve em sua cela de estado-maior na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena em regime fechado desde setembro de 2025. Na manhã do mesmo dia, sua defesa solicitou ao Ministro Alexandre de Moraes autorização para que fosse levado ao Hospital DF Star, em Brasília, para reavaliação por sua equipe médica, mas o pedido foi negado. Diante da repercussão do caso, o Conselho Federal de Medicina recebeu denúncias e determinou que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) instaurasse sindicância para apuração preliminar dos fatos. Posteriormente, por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, o procedimento foi anulado, sob fundamentos de ordem institucional e jurídica, conforme expresso no despacho judicial.

Imagine seu pai ou avô batendo a cabeça ao cair da cama enquanto dorme. A principal preocupação, nesse caso, é saber se houve lesão no crânio. Agora imagine uma situação diferente: ele se levanta, cai e não consegue explicar o que sentiu antes da queda. Aqui, o trauma continua preocupando, mas passa a ser também consequência de algo maior · como um desmaio, uma arritmia ou até um evento neurológico. Como médico, quando estou em plantões de pronto atendimento e me deparo com situações de TCE, essa é uma das primeiras perguntas que faço: foi uma queda puramente mecânica ou houve algo que a precipitou? Porque essa diferença muda o risco e, sobretudo, a urgência da investigação.

O atendimento médico prestado a Jair Bolsonaro por ocasião do traumatismo cranioencefálico (TCE) leve sofrido é descrito no despacho do Ministro Alexandre de Moraes que determinou a anulação da sindicância instaurada pelo CRM-DF para apuração da conduta médica no caso. O documento judicial transcreve um relatório médico elaborado pela equipe da Polícia Federal, não

sendo possível inferir, a partir de seu conteúdo, se tal descrição corresponde à integralidade da evolução clínica registrada em prontuário ou se se trata de excerto selecionado para fins de fundamentação da decisão. Ainda assim, os dados clínicos ali consignados permitem análise técnica consistente da conduta adotada.

No relatório, registra-se que a queda teria ocorrido enquanto o ex-presidente dormia, versão que diverge do relato público da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, segundo o qual Bolsonaro teria se levantado e, em seguida, sofrido a queda. Do ponto de vista médico, variações narrativas em contexto de TCE não costumam ser interpretadas como indício de má-fé, mas como possível expressão de alterações cognitivas transitórias, como confusão mental ou prejuízo de memória. O fato de existirem versões distintas sobre a dinâmica do evento · queda da cama durante o sono ou queda após levantar-se · impõe, por si só, maior cautela clínica quando a mecânica do trauma não está plenamente esclarecida.

Além disso, o próprio relatório médico transcrito descreve fatores objetivos que, na prática clínica cotidiana, elevam de forma significativa o risco de complicações intracranianas e ampliam a indicação de investigação por imagem: uso recente de anticoagulante, relato de tontura no dia anterior, instabilidade ortostática ao exame físico e idade superior a 70 anos. Isoladamente, cada um desses elementos já demanda vigilância acrescida; em conjunto, configuram cenário classicamente enquadrado, nas principais diretrizes internacionais sobre TCE, como indicação robusta para realização de tomografia computadorizada (TC) de crânio em tempo oportuno, com o objetivo de excluir lesões potencialmente graves.

Nesse contexto, pode causar perplexidade técnica o fato de não constar, no relatório transcrito, orientação explícita para a realização de exame de imagem, sobretudo porque os próprios fatores que fundamentam essa conduta foram reconhecidos e descritos no documento. Observa-se que o profissional registrou elementos clínicos relevantes, inserindo-os no contexto da avaliação, ainda que em um cenário que, à luz da prática baseada em evidências, costuma ser associado à indicação de TC de crânio.

Chama igualmente a atenção o fato de que a evolução médica, enquanto gênero técnico, deve atender a requisitos mínimos independentemente do modelo adotado: descrição da queixa principal, história da moléstia atual, antecedentes clínicos relevantes, hipóteses diagnósticas e conduta adotada. No trecho transcrito no despacho, esses elementos não aparecem de forma completa. O texto limita-se à descrição do evento traumático e aos achados colhidos na avaliação inicial, sem explicitar hipóteses diagnósticas nem o racional clínico para a dispensa do exame. A opção por não realizar a TC surge de forma indireta, na narrativa do próprio despacho judicial, e não como conduta clínica detalhadamente justificada na redação médica transcrita.

Diante desses elementos · extraídos de informações tornadas públicas pela imprensa e do

próprio despacho do Supremo Tribunal Federal · e considerando tratar-se de ato médico, mostra-se tecnicamente legítima a instauração de procedimento de sindicância estritamente voltado à análise da conduta profissional adotada no atendimento ao ex-presidente.

Cabe lembrar que, diferentemente do Direito, em que a interpretação admite maior margem de subjetividade, a Medicina opera sob discricionariedade muito mais limitada, ancorada em evidências científicas continuamente atualizadas e consolidadas em protocolos assistenciais. Nesse sentido, o enquadramento clínico descrito no caso se alinha, de forma consistente, à recomendação de TC de crânio em curto prazo nas principais diretrizes que tratam do manejo do TCE, o que torna legítimo o questionamento técnico acerca de conduta diversa.

O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais dispõem, para esse fim, do instrumento da sindicância · procedimento legal, preliminar e técnico, instaurado a partir de denúncia formal, que não se confunde com punição ou acusação. Trata-se de mecanismo institucional essencial, que simultaneamente assegura o direito da sociedade ao escrutínio e protege o médico contra imputações infundadas, permitindo que apenas situações com indícios concretos avancem para investigação formal. Não por acaso, neste caso, o CFM limitou-se a determinar ao CRM-DF a instauração da sindicância, em estrita observância ao rito institucional previsto.

Faço essa consideração para que se compreenda a gravidade do que está em debate. Diante da ampla publicidade do caso, o CFM recebeu denúncias e, portanto, material potencialmente apto à abertura de sindicância · o que de fato ocorreu, conforme comunicado oficial emitido em 7 de janeiro. Em resposta, uma decisão do Ministro Alexandre de Moraes determinou a anulação da sindicância, sob o entendimento de desvio de finalidade e ilegitimidade da atuação da entidade no caso concreto, além de ordenar que o presidente do Conselho prestasse esclarecimentos à Polícia Federal no prazo de dez dias, para apuração de eventual responsabilidade criminal, conforme consta expressamente na decisão judicial.

Como justificativa para seu despacho, o ministro afirma que ·não houve qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, que atuou correta e competentemente·, sustentando tal conclusão a partir do relatório médico amplamente discutido. Do ponto de vista médico, é possível observar que a descrição clínica constante do documento não se encontra plenamente alinhada ao racional que, segundo diretrizes amplamente aceitas, costuma orientar a conduta em situações análogas. Ademais, o despacho faz referência a exames realizados posteriormente em ambiente hospitalar, cuja normalidade é apresentada como elemento corroborativo da adequação da conduta inicial.

Tal encadeamento argumentativo, quando publicizado, pode induzir à interpretação de que a ausência de achados relevantes em exames posteriores serviria como critério retrospectivo para afastar a indicação prévia de investigação por imagem. Na prática médica, entretanto, muitas

condutas são indicadas justamente para evitar desfechos adversos, ainda que estes não venham a se concretizar. A lógica que fundamenta a existência de protocolos preventivos e diretrizes clínicas.

É compreensível que a repercussão pública tenha se concentrado no fato concreto que deu origem a essa sucessão de eventos. Ainda assim, mais preocupante do que o episódio em si é o efeito institucional que decisões dessa natureza podem produzir, bem como a mensagem transmitida a magistrados de instâncias inferiores, que lidam cotidianamente com conflitos semelhantes. Não se trata apenas de anular um procedimento específico, mas de vedar, em âmbito nacional, qualquer atuação dos Conselhos de Medicina com esse mesmo objeto. Atos praticados nas instâncias superiores raramente se esgotam em seus próprios limites: eles orientam condutas, estabelecem balizas e produzem efeitos que se irradiam por todo o sistema.

A história mostra que decisões tomadas no topo do poder possuem relevante efeito pedagógico. Em 13 de dezembro de 1968, o então vice-presidente da República, Pedro Aleixo, afirmou confiar no presidente, mas não no “guardinha da esquina”, ao votar contra a instauração do AI-5. A advertência dizia respeito menos ao conteúdo formal do ato e mais às consequências práticas de sua aplicação em cadeia. A tortura jamais foi formalmente regulamentada no Brasil, mas ocorreu durante a vigência daquele período histórico.

Se o Brasil é, de fato, uma democracia, não deveria ser motivo de temor que um médico se manifeste com base em fatos públicos, diretrizes técnicas e instrumentos legais. Defender o Conselho que representa a classe médica não é corporativismo: é fortalecer um sistema que, amanhã, pode ser a principal linha de defesa do próprio exercício profissional. Viver em sociedade pressupõe observância e empatia, porque o lugar do outro hoje pode ser o nosso amanhã.

Dito isso, faço uma pergunta direta a você, que é médico: caso não haja um reposicionamento institucional quanto à postura até aqui adotada, você se sente plenamente seguro para tomar decisões clínicas fundamentadas em diretrizes validadas, independentemente de quem seja o paciente? E você, que não é médico, pergunto: se, no futuro, precisar de um laudo médico para sustentar sua própria defesa judicial, considera preservada a independência técnica do profissional responsável por esse documento? Por fim, é importante destacar que decisões judiciais de ampla publicidade, especialmente quando tratam de matéria técnica sensível, produzem efeitos que extrapolam o caso concreto e influenciam a percepção social sobre práticas profissionais e institucionais.

Como síntese do problema aqui discutido, talvez seja legítimo questionar se nossas instituições têm conseguido operar de forma consistente em favor do interesse público, como se espera em uma democracia madura. Em um cenário político marcado por tensões recorrentes e crises

institucionais, cabe a nós, cidadãos comuns, o esforço de sustentar um debate sério, responsável e tecnicamente fundamentado · mesmo quando isso pareça inútil ou desestimulante. Democracia não se preserva pela indiferença, mas pela vigilância qualificada.